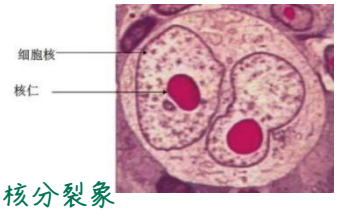
（三）病理特点



1.HL 几乎来源 **B** 细胞

2.**RS 细胞**　细胞大、细胞核大、核仁大

（1）典型（三大一红无分裂）　规律:肿瘤(尤其恶性)有核分裂,甚至是病理性核分裂象

①**双核（镜影细胞）或多核瘤巨细胞**、核大呈空泡状、核仁明显呈红色伴周围空晕、**无核分裂象** 特殊

②嗜双性　eg.甲状腺乳头状癌细胞核的染色质少,呈透明毛玻璃样

（2）不典型

①霍奇金细胞（单核）

②变异 RS 细胞：陷窝细胞、爆米花细胞、木乃伊/干尸细胞（变性凋亡的 RS 细胞）

3.**结节性淋巴细胞为主型 NLPHL**

①**爆米花**细胞（核分叶多像爆米花、越成熟越懂事）

②预后 ttsx **最好** 越小越成熟,越成熟核就越会分叶

4.**经典型霍奇金淋巴瘤 CHL**

（1）概述（共性和个性）

①**EBV** 感染 比伯单穿CK

②**典型 RS 细胞** VS NLPHL爆米花细胞(不典型RS细胞)

③**多种炎细胞混合浸润为背景**

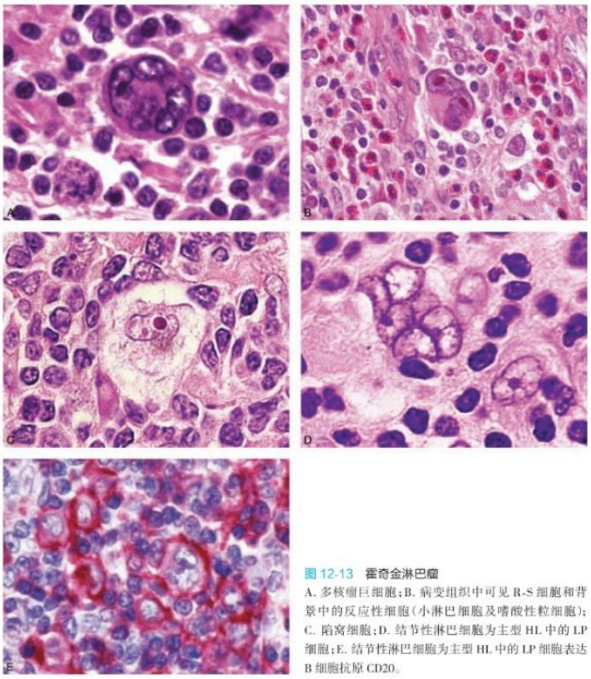


图 12-13　霍奇金淋巴瘤
A. 多核瘤巨细胞；B. 病变组织中可见 R-S 细胞和背景中的反应性细胞（小淋巴细胞及嗜酸性粒细胞）；C. 陷窝细胞；D. 结节性淋巴细胞为主型 HL 中的 LP 细胞；E. 结节性淋巴细胞为主型 HL 中的 LP 细胞表达 B 细胞抗原 CD20。

（2）发病率 先买婚戒再结婚-先有临床表现再做病理

《内科学》：混合细胞型>结节硬化型>富于淋巴细胞型>淋巴细胞减少型（婚戒）

《病理学》：结节硬化型>混合细胞型>富于淋巴细胞型>淋巴细胞减少型（结婚）

（3）**预后：富于淋巴细胞型>结节硬化型>混合细胞型>淋巴细胞减少型**（结婚）

（4）CHL 的病理类型 都有RS细胞,但各个类型的特征可不同

	结节硬化型	混合细胞型	富于淋巴细胞型	淋巴细胞减少型
特征	**陷窝**细胞	典型 RS 和单核 RS	大量淋巴细胞	典型 RS 或多形性瘤细胞
特点	**EBV 感染率低** **青年妇女、纵隔肿块**多见（姐姐） 粗大**胶原纤维**束将淋巴结分隔为**硬化**大小不等的结节 **不**转变为其它亚型	肿瘤细胞与炎细胞混合存在 VS多种炎细胞混合浸润为背景是共性		**EBV 感染率接近 100%** **HIV 者多见**